



聚焦 WCLC 与 ESMO，中国新药持续突破

——医药行业月报 26/09

2026 年 09 月 29 日

核心观点

- **多款国产新药亮相 2026WCLC，肺癌治疗领域迎来新突破。**2026 年 9 月 12 日至 15 日举行的世界肺癌大会上，中国新药共有 19 项口头报告和 45 项小型口头报告入选，翰森制药和宜联生物的两款 B7H3 ADC 治疗复发性 SCLC III 期研究进入最高规格主席研讨会，其中翰森制药的瑞康立伏妥单抗将 SCLC 患者中位总生存期由化疗的 10.3 个月延长至 18.5 个月，死亡风险下降 54%，体现国产创新药正由早期疗效信号迈向确证性生存获益验证。同时 IO 2.0 管线继续取得突破，康方生物的依沃西单抗对头帕博利珠单抗一线治疗 PD-L1 阳性 NSCLC 实现 PFS 和 OS 双阳性，中位 OS HR 为 0.73，在 PD-L1 高表达患者 HR 进一步降至 0.58，有望成为肿瘤免疫标准疗法。另外，ADC 联合双抗成为重要迭代方向，映恩生物的 B7-H3 ADC 联合 BioNtech 的 pumitamidg 双抗初步疗效和安全性数据优异，具备广阔的联合治疗空间。
- **2026ESMO 即将启幕，国产新药有望再创记录。**2026 年欧洲肿瘤内科学会年会将于 10 月 23 至 27 日在西班牙马德里举行，本届大会预计共 29 项中国新药研究入选 LBA，约占大会全部 LBA 的三分之一，其中 5 项进入主席研讨会，其余 24 项以优选口头或快速口头形式报告，入选数量和占比继 2025 年后再创历史新高。创新药前瞻亮点重点关注三条主线：1) 国产 ADC 进入 III 期临床集中兑现期，科伦博泰 TROP2 ADC、百利天恒 EGFR/HER3 ADC 等将披露关键数据；2) IO 2.0 由肺癌向多瘤种扩张，康方生物依沃西单抗联合化疗一线治疗晚期胆道癌 III 期研究已取得 OS 阳性并进入主席研讨会。3) 精准治疗进一步向耐药和难治肿瘤推进，和黄医药赛沃替尼联合奥希替尼有望验证 EGFR+MET 双通路阻断实现全线治疗覆盖的临床价值；劲方医药 pan-RAS 分子胶抑制剂 GFH276、恒瑞医药 KRAS G12D 抑制剂 HRS-4642 将披露早期数据，精准治疗向 RAS 领域延伸。
- **医药行业表现弱于沪深 300。**截至 2026 年 09 月 29 日，医药行业一年滚动市盈率为 32.84 倍，沪深 300 为 13.13 倍。医药市盈率相对于沪深 300 溢价率当前值为 150.16%，历史均值为 174.56%，当前值较 2005 年以来的平均值低 0.24 个百分点。2023 年初至 2026 年 09 月 29 日，SW 医药生物指数下跌 14.25%，沪深 300 上涨 12.12%，医药板块相对沪深 300 收益低 26.37 个百分点。
- **投资建议：**医药行业上半年大幅回调后，不论创新药及非创新药估值均回落至历史低位，下半年关注医保变量及创新药临床数据兑现，投资思路寻找医药硬科技、并考虑企业现金价值，推荐关注创新药（BIC 和 FIC 管线龙头）、创新药产业链（CXO、生命科学上游）、创新器械出海（影像、高值耗材、消费器械等）、医疗 AI 方向，关注医疗服务复苏及第三方 ICL。
- **风险提示：**宏观经济压力增大医药消费能力增长不足的风险、创新药医保支付等政策不及预期的风险、地缘政治带来的全球订单转移风险、集采或收费降价超出市场预期的风险。

医药行业

推荐 维持评级

分析师

程培

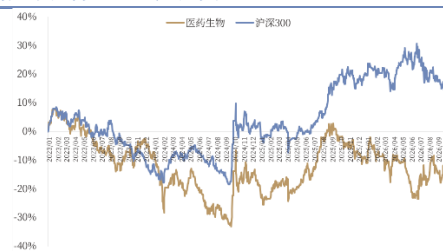
分析师登记编码：S0130522100001

闫晓松

分析师登记编码：S0130522100001

相对沪深 300 表现图

2026-09-29



资料来源：中国银河证券研究院

相关研究

2026-9 行业 8 月动态报告：创新药产业链高景气，行业 K 型分化

2026-8 行业 7 月动态报告：医药持仓占比历史新低，医保支出显著下滑

2026-7 行业 6 月动态报告：小核酸药及实体瘤 CART 实现突破性进展

2026-6 行业 5 月动态报告：国产新药闪耀 ASCO，医保规则进一步优化

目录

Catalog

一、 月度政策及行业更新 3

 (一) 多款国产新药亮相 2026WCLC，肺癌治疗领域迎来新突破3

 (二) 2026ESMO 即将启幕，国产新药有望再创历史记录5

二、 行业数据动态 8

 (一) 医药行业表现弱于沪深 3008

 (二) 医药制造业收入同比持平8

 (三) 门诊费用仍有所提升，住院费用得到遏制9

 (四) 2025 年诊疗及出院人次提升，体现医疗服务量显著恢复 10

 (五) 医保基金整体运行平稳 11

三、 投资建议 12

四、 风险提示 13



知识星球：前沿信息收录
更多一手研报资料扫码加微信

请阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。

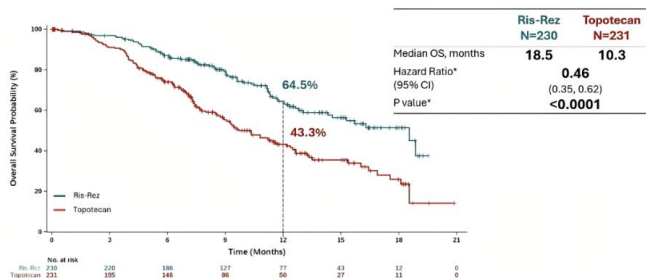
一、月度政策及行业更新

（一）多款国产新药亮相 2026WCLC，肺癌治疗领域迎来新突破

2026 年 9 月 12 日至 15 日，世界肺癌大会（WCLC）在韩国首尔举行，由中国学者主导的 19 项口头报告、45 项小型口头报告入选，创下历史记录；其中两项国产 B7H3 ADC 的 III 期研究进入最高规格的主席研讨会，引发资本市场高度关注。

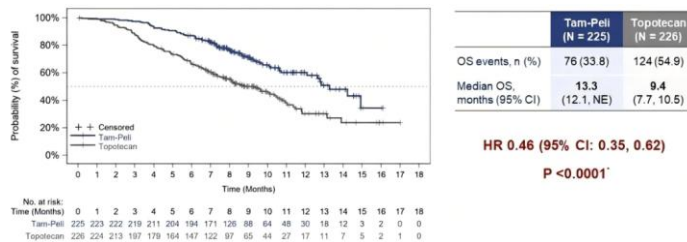
国产 B7H3 ADC 在小细胞肺癌中完成确定性临床验证，其中翰森制药的瑞康立伏妥单抗在 ARTEMIS-008 研究中，将中位 OS 由化疗组的 10.3 个月延长至 18.5 个月，死亡风险下降 54%，中位 PFS 为 7.2 个月对 3.0 个月，ORR 为 58.3%对 12.6%。宜联生物的依康坦博妥单抗在 TAISHAN-302 研究中，同样将死亡风险下降 54%，中位 OS 为 13.3 个月对 9.4 个月，中位 PFS 为 7.4 个月对 2.8 个月，ORR 为 59.1%对 9.7%。两项 III 期研究均获得 OS 阳性，预示着 B7-H3 ADC 已从早期疗效信号升级为有望改变小细胞肺癌二线标准的确证性平台。

图1：翰森制药瑞康立伏妥单抗 ARTEMIS-008 研究 OS 曲线



资料来源：2026WCLC，中国银河证券研究院

图2：宜联生物依康坦博妥单抗 TAISHAN-302 研究 OS 曲线



资料来源：2026WCLC，中国银河证券研究院

IO 2.0 管线继续取得突破，康方生物的依沃西单抗在 HARMONi-2 III 期研究中，针对 PD-L1 阳性的晚期非小细胞肺癌头对头帕博利珠单抗取得 PFS、OS 双阳性，两组中位 OS 分别为 30.8 个月和 22.6 个月，HR 为 0.73，其中 PD-L1 高表达人群 HR 进一步降至 0.58，在大样本 III 期临床证明其生存获益显著优于主流 PD-1 单抗，具备成为肿瘤免疫标准疗法潜力。荣昌生物 RC148 联合化疗一线治疗非小细胞肺癌，其中鳞癌组获得 90.0%ORR 和 11.8 个月中位 PFS，PD-L1 阴性患者 ORR 达 93.3%；非鳞癌组获得 75.9%ORR 和 11.1 个月中位 PFS，PD-L1 阴性患者 ORR 达 71.4%；有望突破免疫治疗在 PD-L1 阴性领域疗效限制。

另外，ADC 与双抗联合成为下一代的重要技术方向；映恩生物的 B7-H3 ADC 联合 BioNtech 的 pumitamig 双抗，在 71 例可评估小细胞肺癌患者中取得 70.4% ORR，其中一线患者 ORR 达到 92.3%，三级以上 TRAE 仅 23.3%，后续具备广阔的联合用药空间。

表1：2026WCLC 部分国产重点创新药数据整理

公司	产品	靶点	类型	适应症	研究阶段	报告形式	临床数据
康方生物 /Summit	依沃西单抗	PD-1/VEGF	双抗	一线 PD-L1 TPS≥1%、EGFR/ALK 阴性局晚期或转移性 NSCLC	III期 HARMONi-2	LBA Oral	mOS 30.8 vs 22.6 个月，HR=0.73；3 年 OS 率 45.0% vs 33.1%；TPS ≥50%亚组 OS HR=0.58。
翰森制药 /GSK	瑞康立伏妥塔单抗	B7-H3	ADC	含铂治疗后复发 SCLC	III期 ARTEMIS-008	LBA	ORR 58.3% vs 12.6%；mPFS 7.2 vs 3.0 个月，HR=0.33；mOS 18.5 vs 10.3 个月，HR=0.46；≥3 级 TRAE 60.9% vs 78.2%。
宜联生物/ 罗氏	依康坦博妥塔单抗	B7-H3	ADC	一线含铂治疗后复发 SCLC	III期 TAISHAN-302	LBA	ORR 59.1% vs 9.7%；mPFS 7.4 vs 2.8 个月，HR=0.29；mOS 13.3 vs 9.4 个月，HR=0.46；≥3 级 TRAE 46.4% vs 74.7%。
映恩生物 /BioNTech	ElfeD+ Pumitamig	B7-H3+ PDL1/VEGF	ADC+ 双抗	晚期或转移性 SCLC	Ib/II期 BNT324-01	LBA	ORR 70.4%、DCR 93.0%；一线 ORR 92.3%，二线 76.2%，三线及以上 52.4%；≥3 级 TRAE 39.7%，ILD 肺炎 2.6%。
荣昌生物/ 艾伯维	RC148+ 化疗	PD-1/VEGF	双抗联合化疗	一线局晚期或转移性鳞状/非鳞 NSCLC	II期 RC148-C002	Oral	鳞癌 10 mg/kg 组 ORR 90.0%、cORR 76.7%、mPFS 11.8 个月；PD-L1 阴性鳞癌 ORR 93.3%；非鳞 10 mg/kg 组 ORR 75.9%。
维立志博	Opamtistomig+化疗	PD-L1/4-1BB	双抗	一线晚期 NSCLC	II期	Mini Oral	整体 ORR 71.0%、DCR 95.2%、6 个月 PFS 率 70.6%；鳞癌 ORR 87.1%、6 个月 PFS 率 86.7%。
石药集团	SYS6010+恩朗苏拜单抗	EGFR+PD-1	ADC+ 单抗	一线驱动基因阴性的晚期 NSCLC	I /II期	Oral	两个给药组 PD-L1 TPS≥50%患者 cORR 分别为 77.8%和 82.4%；高表达非鳞癌亚组 ORR 81.8%和 91.7%；≥3 级 TRAE 51.6%和 52.5%。
宜联生物/ 罗氏	YL201+斯鲁利单抗	B7-H3+ PD-1	ADC+ 单抗	一线 ES-SCLC 及晚期 NSCLC	I 期	Mini Oral	ES-SCLC: ORR 85.4%、mPFS 12.9 个月；非鳞/鳞状 NSCLC ORR 分别 58.3%/57.9%，鳞癌 mPFS 11.7 个月；≥3 级 TRAE 38.3%。
百利天恒 /BMS	Iza-Bren	EGFR/HER3	双抗 ADC	经治 EGFR 突变晚期 NSCLC	全球 I 期	Oral	cORR 29.6%、mPFS 6.9 个月；早期单臂剂量扩展结果，需后续随机研究确认。
科伦博泰/ 默沙东	芦康沙妥珠单抗	TROP2	ADC	经治、携带非经典 EGFR 等罕见靶向基因突变晚期 NSCLC	II期	Oral	ORR 34.4%、mPFS 9.4 个月；ALK 融合亚组 ORR 40.0%。
恒瑞医药	SHR-A2009 SHR-A1921 序贯或联合方案	HER3/TROP 2	ADC	ADC 经治或标准治疗后晚期 NSCLC	I /II期	Poster	序贯治疗 EGFR 突变人群 PFS 超过 9 个月；联合方案鳞癌 mPFS 7.3 个月。



司读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。

翰森制药	HS-10370+阿得贝利单抗+化疗	KRAS G12C+PD-L1	小分子抑制剂+单抗+化疗	一线 KRAS G12C 突变晚期 NSCLC	Ib 期	Oral	ORR 87.0%；12 个月 PFS 率 80.2%，OS 尚未成熟。
劲方医药/Verastem	GFH375	KRAS G12D	小分子抑制剂	二线及以上 KRAS G12D 突变晚期 NSCLC	I /II 期	Oral	ORR 59.2%、cORR 52.1%、DCR 93.0%；mPFS8.3 个月，未接受紫杉类药物亚组 9.6 个月。
首药控股	Ficonalkib	ALK	第三代 ALK-TKI	二代 ALK-TKI 失败的 ALK 阳性晚期 NSCLC	关键 II 期	Mini Oral	ORR 43.1%、DCR 75.2%、mPFS 9.7 个月、mDoR 15.2 个月；脑转移可评估患者颅内 ORR 65.0%；≥ 3 级 TRAE 30.1%。
艾力斯	伏美替尼+Vebreltinib	EGFR+MET	双小分子 TKI	EGFR-TKI 耐药后伴 MET 扩增 NSCLC	Ib/II 期	会议报告	ORR 51.5%，RP2D 组 ORR 59.1%、DCR 100%；≥3 级 TRAE 3.0%。

资料来源：WCLC 官网，中国银河证券研究院

（二）2026ESMO 即将启幕，国产新药有望再创历史记录

2026 年 10 月 23 日至 27 日，欧洲肿瘤内科学会（ESMO）年会在西班牙启幕，本届大会预计 29 项中国新药研究入选 LBA (Late-Breaking Abstract)，包括 5 项主席研讨会和 24 项口头报告、快速口头报告，国产新药继 2025 年后再次创下 LBA 入选数量和占比的历史新高，主要关注点如下：

1) 国产 ADC 进入 III 期临床集中兑现期，其中科伦博泰 TROP2 ADC 芦康沙妥珠单抗、百利天恒 EGFR/HER3 双抗 ADC 伦康依隆妥单抗、恒瑞医药 HER2 ADC/HER3 ADC、翰森制药 B7-H3 ADC、康诺亚/乐普生物 CLDN18.2 ADC，以及宜联生物 B7-H3 ADC 均将披露关键数据。

2) IO 2.0 由肺癌向多瘤种扩张，康方生物依沃西单抗联合化疗一线治疗晚期胆道癌的 III 期 HARMONI-GI1 研究 OS 取得阳性结果，并已进入主席研讨会；依沃西单抗在晚期肾细胞癌和复发转移性胸腺癌数据也将以口头报告方式披露。另外维立志博 PD-L1/4-1BB 双抗 LBL-024、信达生物 PD-1/IL-2 双融合蛋白 IBI363 将分别探索肺外神经内分泌癌、胃癌等领域。

3) 精准治疗进一步向耐药和难治肿瘤推进，和黄医药赛沃替尼联合奥希替尼的全球 III 期 SAFFRON 研究，用于奥希替尼治疗后进展且伴 MET 扩增的 EGFR 突变 NSCLC，PFS、OS 均显著改善；其一线 SANOVO III 期研究则面向初治 EGFR 突变、MET 过表达患者；两项研究同时入选 LBA，有望验证 EGFR+MET 双通路阻断实现全线覆盖治疗场景。另外，劲方医药 pan-RAS 分子胶抑制剂 GFH276、恒瑞医药 KRAS G12D 抑制剂 HRS-4642 也将披露早期数据。

表2：2026ESMO 部分国产重点创新药 LBA 前瞻

公司	产品	靶点	类型	适应症	研究阶段	报告形式
和黄医药/阿斯利康	赛沃替尼+奥希替尼	MET+EGFR	双小分子 TKI	奥希替尼治疗后进展、伴 MET 过表达或扩增的 EGFR 突变 NSCLC	III 期，SAFFRON	主席研讨会，LBA6
康诺亚/乐普生物/阿斯利康	Sonestitug vedotin	CLDN18.2	ADC	二线及以上 CLDN18.2 阳性晚期胃或胃食管结合部癌	III 期，CLARITY-Gastric 01	主席研讨会，LBA7

康方生物/Summit	依沃西单抗+化疗	PD-1/VEGF	双抗+化疗	一线晚期胆道癌，对照度伐利尤单抗+化疗	III期, HARMONI-GI1	主席研讨会, LBA8
翰森制药/GSK	瑞康立伏妥单抗	B7-H3	ADC	经多线治疗的复发或难治性骨肉瘤/肉瘤	III期, ARTEMIS-011	主席研讨会, LBA9
科伦博泰/默沙东	芦康沙妥珠单抗	TROP2	ADC	既往治疗的晚期或复发性子宫内膜癌	III期, TroFuse-005	主席研讨会, LBA11
恒瑞医药	瑞康曲妥珠单抗	HER2	ADC	HER2 低表达晚期乳腺癌	III期, HORIZON-Breast06	优选口头, LBA13
康宁杰瑞/石药集团	安尼妥单抗+白蛋白结合型多西他赛	HER2	双特异性抗体+化疗	HER2 阳性晚期乳腺癌	III期	优选口头, LBA15
中国生物制药/正大天晴	TQB2102	HER2	双表位 ADC	HER2 低表达复发或转移性乳腺癌	III期, APEX-Breast01	优选口头, LBA27
劲方医药	GFH276	Pan-RAS	小分子抑制剂	经治 RAS 突变晚期实体瘤	早期临床	快速口头, LBA33
乐普生物/美雅珂/ArriVent	MRG007	CDH17	ADC	局部晚期或转移性实体瘤	首次人体 I 期	快速口头, LBA34
翰森制药/GSK	HS-20089 (Mo-Rez)	B7-H4	ADC	铂耐药卵巢癌	早期临床, BEHOLD-1	快速口头, LBA41
宜联生物/罗氏	依康坦博妥单抗	B7-H3	ADC	重度经治复发或转移性鼻咽癌	III期, TAISHAN-301	优选口头, LBA43
百济神州	替雷利珠单抗+围术期化疗	PD-1	单抗+化疗	局部晚期可切除口腔鳞癌	II 期, OPTIMAL	快速口头, LBA47
百利天恒/BMS	伦康依隆妥单抗	EGFR/HER3	双特异性 ADC	经治 HR 阳性/HER2 阴性晚期乳腺癌	III期, PANKU-Breast01	优选口头, LBA50
微芯生物/HUYABIO	西达本胺+纳武利尤单抗	HDAC+PD-1	表观遗传小分子+单抗	晚期黑色素瘤	III期, HBI-8000-303	优选口头, LBA54
维立志博	LBL-024	PD-L1/4-1BB	双特异性抗体	二线及以上晚期肺外神经内分泌癌	注册 II b 期	优选口头, LBA57
荣昌生物/辉瑞	维迪西妥单抗 (RC48)	HER2	ADC	HER2 高表达晚期乳房外 Paget 病	单臂 II 期, Formula-10	快速口头, LBA61
君实生物	特瑞普利单抗+化疗	PD-1	单抗+围术期化疗	可切除 II—III期 NSCLC	III期, Neotorch 终分析	优选口头, LBA64
科伦博泰/默沙东	芦康沙妥珠单抗+帕博利珠单抗	TROP2+PD-1	ADC+单抗	一线 PD-L1 阴性晚期非鳞 NSCLC	III期, OptiTROP-Lung06	优选口头, LBA66



请阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。

科伦博泰/ 默沙东	芦康沙妥珠单抗	TROP2	ADC	EGFR-TKI 治疗后进展的 EGFR 突变 NSCLC	III期, OptiTROP- Lung04 最 终 OS 分析	优选口头, LBA67
和黄医药/ 阿斯利康	赛沃替尼+奥希替尼	MET+EGFR	双小分子 TKI	一线 EGFR 突变、MET 过表达晚期 NSCLC	III期, SANOVO	优选口头, LBA69
百利天恒 /BMS	伦康依隆妥单抗	EGFR/HER3	双特异性 ADC	三代 EGFR-TKI 治疗后进展的 EGFR 突变 非鳞 NSCLC	III期, PANKU- Lung01	优选口头, LBA71
恒瑞医药	瑞康罗泽妥塔单抗	HER3	ADC	EGFR-TKI 治疗后进展的 EGFR 突变晚期 NSCLC	III期, HERON- Lung01	优选口头, LBA72
普米斯生物 /BioNTech /BMS	Pumitamidg+多西他赛	PD-L1× VEGF	双抗+化疗	化疗及免疫治疗后转移性 NSCLC	全球II期, ROSETTA Lung-107	快速口头, LBA76
信达生物/ 武田	IBI343	CLDN18.2	ADC	三线及以上 CLDN18.2 阳性胃或胃食管结合 部腺癌	III期, G- HOPE-001	优选口头, LBA77
百济神州 /Jazz/Zym eworks	Zanidatamab+化疗± 替雷利珠单抗	HER2±PD-1	双特异性抗体+ 化疗±单抗	一线 HER2 阳性胃食管腺癌	III期, HERIZON- GEA-01	快速口头, LBA79
康宁杰瑞/ 石药集团	安尼妥单抗+化疗	HER2	双特异性抗体+ 化疗	既往治疗的 HER2 阳性胃或胃食管结合部癌	III期, KC- WISE	快速口头, LBA80
恒瑞医药	HRS-4642+化疗±阿得 贝利单抗	KRAS G12D ±PD-L1	小分子抑制剂+ 化疗±单抗	KRAS G12D 突变胰腺癌围术期治疗	II期	快速口头, LBA85

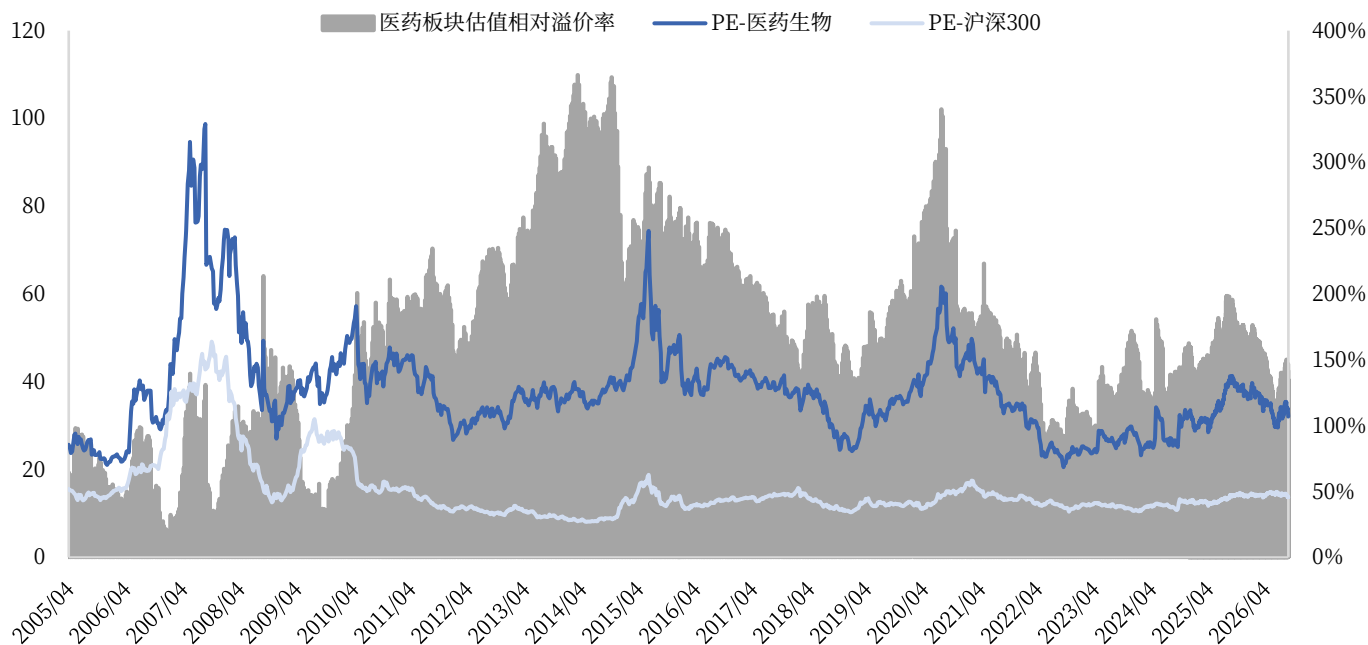
资料来源: ESMO 官网, 中国银河证券研究院

二、行业数据动态

（一）医药行业表现弱于沪深 300

截至 2026 年 09 月 29 日，医药行业一年滚动市盈率为 32.84 倍，沪深 300 为 13.13 倍。医药股市盈率相对于沪深 300 溢价率当前值为 150.16%，历史均值为 174.56%，当前值较 2005 年以来的平均值低 0.24 个百分点。2023 年初至 2026 年 09 月 29 日，SW 医药生物指数下跌 14.25%，沪深 300 上涨 12.12%，医药板块相对沪深 300 收益低 26.37 个百分点。

图3：医药生物指数和沪深 300 滚动市盈率对比（截至 2026 年 09 月 29 日）



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

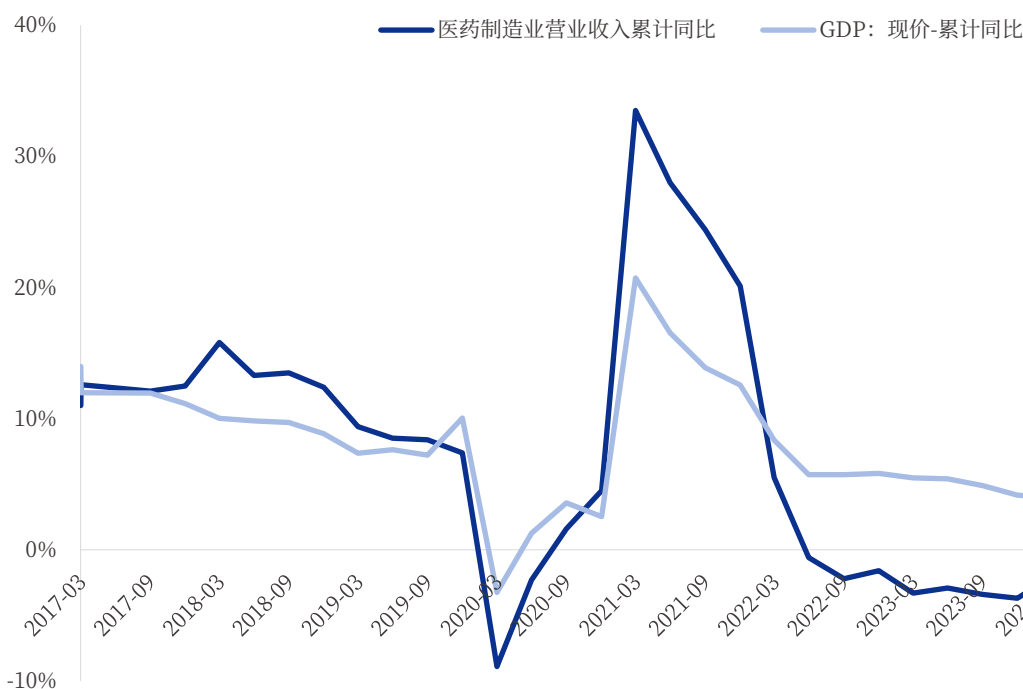
（二）医药制造业收入同比持平

近 10 年来，我国人民物质生活的改善，带动了持续不断的医疗升级需求，医药行业常年保持快于 GDP 增速的增长。医疗需求一方面来自于人口增加带来的基本医疗需求，另一方面来自于医疗升级需求带来的人均消费的提高。随着基数增大，我国医药制造业主营增速逐渐放缓，但仍然保持快于 GDP 的增速。同时，17、18 年收入增速提高与两票制下“低开转高开”有较大关系。2020 前三季度受公共卫生事件冲击影响，医疗机构作为高风险地区纷纷限制营业，其他传染病也因为防护措施得到遏制，医药需求出现下滑，医药制造业收入增速大幅回落并低于 GDP 增速，至 2020 年第四季度才再次反超 GDP 现价累计增速。2021 年医药制造业收入增速强劲复苏，且保持高于 GDP 的增速，2022 年以来行业增速再次回落，至今仍处于低于 GDP 增速的水平。2022Q2 至 2024Q2，医药制造业营业收入累计同比一度处于下降状态，2024Q3 转负为正，2024Q4 同比持平，2025 以来处于同比下滑趋势，2026H1 医药制造业收入同比持平。



请阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。

图4：中国医药制造业营业收入和 GDP 累计增速对比（现价计算）

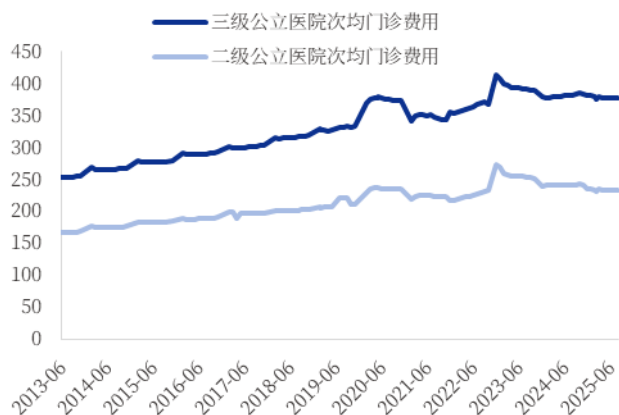


资料来源：国家统计局，中国银河证券研究院

（三）门诊费用仍有所提升，住院费用得到遏制

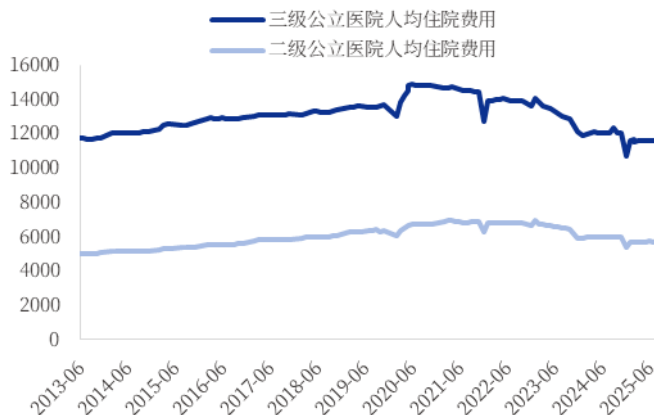
门诊费用受公共卫生事件影响加速上升，住院费用上升势头得到遏制。从 2013 年至 2026 年 1-3 月，中国三级公立医院和二级公立医院医疗费用统计中，次均门诊费用从 255.7 元和 168.1 元分别提高到 376.2 元和 231.5 元；人均住院费用从 11752.2 元和 5043.6 元分别变化到 11542.8 元和 5689.7 元。整体而言，门诊费用在公共卫生事件严重期间上升较快，剔除公共卫生事件影响仍呈现上升趋势，2023 年初次均门诊费用上升至历史最高水平，或主要是呼吸道感染病盛行导致；住院费用上升势头则得到有效控制，并表现出下降趋势，体现了 DRG 等医改控费效果。

图5：2013.6-2026.3 次均门诊费用统计（元）



资料来源：卫健委，中国银河证券研究院

图6：2013.6-2026.3 人均住院费用统计（元）

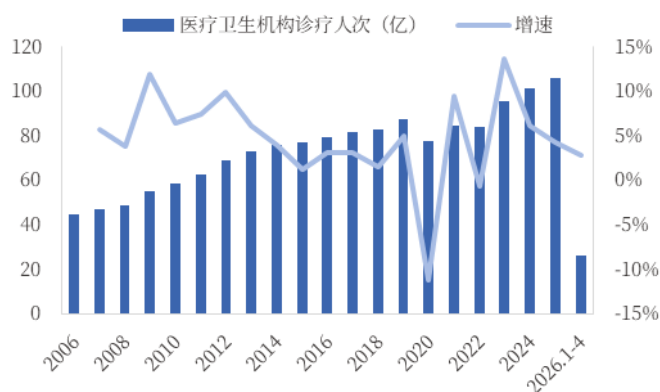


资料来源：卫健委，中国银河证券研究院

（四）2025 年诊疗及出院人次提升，体现医疗服务量显著恢复

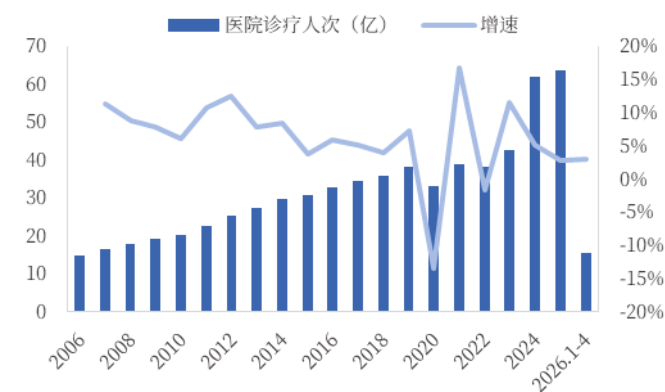
2025 年医疗服务增速逐步恢复。自 2016 年至 2019 年，医疗机构服务数据增速维持低位运行，2022 年受公共卫生事件影响，整体诊疗人数略有下降，2023 年起医疗服务呈现显著恢复。2025 年，全国医疗卫生机构总诊疗人次 105.8 亿人次，同比增长 4.2%，其中医院诊疗人次 63.7 亿，同比增长 2.90%。2025 年，全国医疗卫生机构出院 3 亿人次，同比下降 3.8%，其中医院出院 2.48 亿人次，同比下降 2.9%。2026 年 1-4 月，全国医疗卫生机构总诊疗人次 25.9 亿人次，同比增长 2.8%，其中医院诊疗人次 15.6 亿，同比增长 3.10%。2026 年 1-4 月，全国医疗卫生机构出院 10350 万人次，同比增长 1.9%，其中医院出院 8520 万人次，同比增长 2.30%。

图7：2006-2026.1-4 全国医疗卫生机构总诊疗人次变化情况



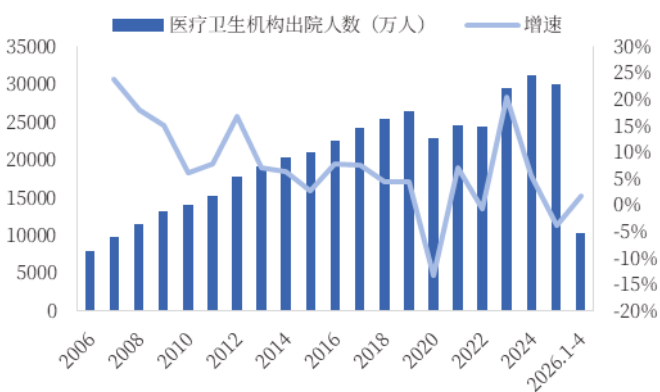
资料来源：卫健委，中国银河证券研究院

图8：2006-2026.1-4 全国医院诊疗人次变化情况



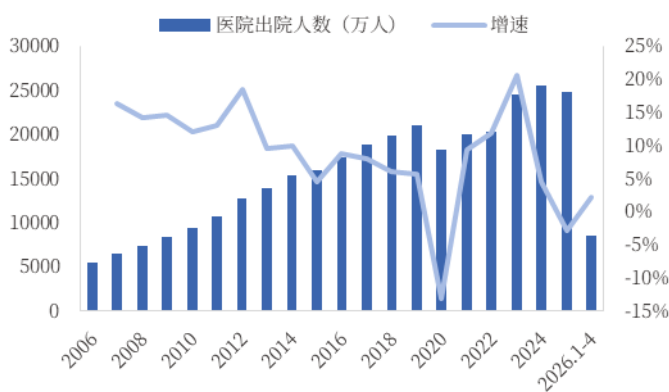
资料来源：卫健委，中国银河证券研究院

图9：2006-2026.1-4 全国医疗卫生机构出院人数变化情况



资料来源：卫健委，中国银河证券研究院

图10：2006-2026.1-4 全国医院出院人数变化情况



资料来源：卫健委，中国银河证券研究院



请阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。

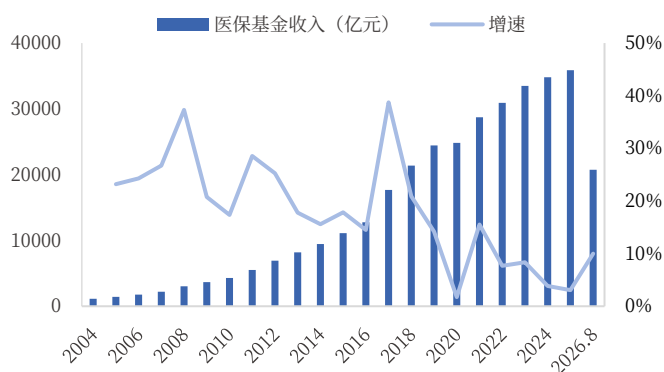
知识星球：前沿信息收录
更多一手研报资料扫码加微信

（五）医保基金整体运行平稳

2024 年医保基金收入 34913.37 亿元，同比增长 4.4%；医保基金支出 29764.03 亿元，同比增长 5.5%。据国家医保局《2024 年全国医疗保障事业发展统计公报》，2024 年医保基金运行安全稳健，统筹基金实现合理结余，其中基本医疗保险统筹基金总收入达到 2.8 万亿元，总支出 2.3 万亿元，统筹基金当期结余 4639.17 亿元，累计结余 3.86 万亿元。职工医保统筹基金累计结余 3.05 万亿元；居民医保统筹基金累计结余 0.82 万亿元，基金运行整体平稳。

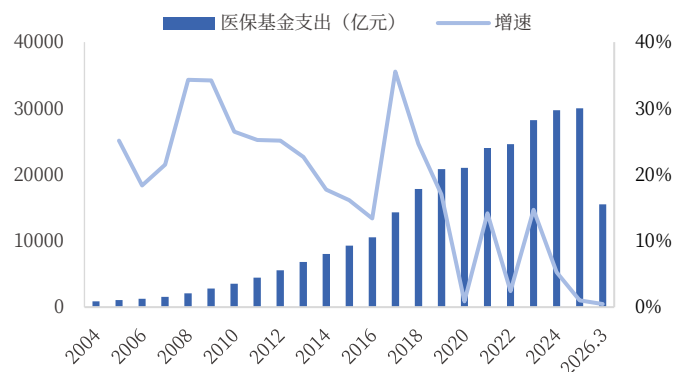
2025 年，全国基本医保基金总收入 35873.11 亿元，同比增长 2.7%。其中职工医保基金收入 2.45 万亿元，居民医保基金收入 1.14 万亿元。全国基本医保基金总支出 30009.38 亿元，同比增长 0.8%。多年来首次扭转收支增幅倒挂态势，支出增速与收入增速的协调性显著增强，支出增长与经济增长的增速协调性也持续改善。2026 年 1-8 月，我国基本医疗保险统筹基金总收入 20728 亿元，同比增长 10%；基本医疗保险统筹基金总支出 15504 亿元，同比增长 0.5%。

图11：2004-2026.1-8 医保基金收入及增速



资料来源：医保局，中国银河证券研究院

图12：2004-2026.1-8 医保基金支出及增速



资料来源：医保局，中国银河证券研究院

三、投资建议

医药行业上半年大幅回调后，不论创新药及非创新药估值均回落至历史低位，下半年关注医保变量及创新药临床数据兑现，投资思路寻找医药硬科技、并考虑企业现金价值，推荐关注创新药（BIC 和 FIC 管线龙头）、创新药产业链（CXO、生命科学上游）、创新器械出海（影像、高值耗材、消费器械等）、医疗 AI 方向，关注医疗服务复苏及第三方 ICL。

看好的方向及推荐公司：

1) 创新药（全产业链核心主线，政策+BD+商业化三重利好）：信达生物、科伦博泰、映恩生物、百济神州、恒瑞医药、诺诚健华、先声药业、亚盛医药、特宝生物、艾力斯、迪哲医药、热景生物等；

2) CXO（创新产业链刚需，订单高增长、业绩拐点明确）：药明康德、康龙化成、凯莱英、昭衍新药、药明生物、药明合联等；

3) 生命科学上游（国产替代加速，仪器/试剂耗材景气上行）：纳微科技、奥浦迈、百普赛斯、阿拉丁、皓元医药、毕得医药等；

4) 器械出海+脑机接口（长期高成长）：联影医疗、迈瑞医疗、南微医学、新产业、安图生物、翔宇医疗、伟思医疗等；

5) 民营医疗服务（医保支出回暖，消费医疗触底回升）：爱尔眼科、通策医疗、美年健康等。

6) ICL 连锁第三方诊断（经营有望触底，长期价值突出）：金域医学、迪安诊断。



阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。

四、风险提示

1.宏观经济压力增大致医药消费能力增长不足的风险。宏观经济压力可导致地方财政紧张，医保政策如 DRG/DIP 的严格执行对医药消费造成较大压力。居民自主消费意愿可能会下降，影响医药消费的增长。

2.创新药医保支付等政策不及预期的风险。医保基金的可持续性、支付标准、商业保险、政策执行以及监管等方面，共同影响创新药的市场准入和支付情况。

3.地缘政治带来的全球订单转移风险。贸易政策的变化以及地缘政治的不确定性对医药行业产生影响，导致市场成长天花板和订单持续性风险，全球医药创新链、产业链、供应链或加快重塑。

4.集采或收费降价超出市场预期的风险。集采或收费降价超出市场预期或导致企业的利润被挤压，影响市场竞争、药品质量和供应保障等。

图表目录

图 1： 翰森制药瑞康立伏妥单抗 ARTEMIS-008 研究 OS 曲线	3
图 2： 宜联生物依康坦博妥单抗 TAISHAN-302 研究 OS 曲线	3
图 3： 医药生物指数和沪深 300 滚动市盈率对比（截至 2026 年 09 月 29 日）	8
图 4： 中国医药制造业营业收入和 GDP 累计增速对比（现价计算）	9
图 5： 2013.6-2026.3 次均门诊费用统计（元）	9
图 6： 2013.6-2026.3 人均住院费用统计（元）	9
图 7： 2006-2026.1-4 全国医疗卫生机构总诊疗人次变化情况	10
图 8： 2006-2026.1-4 全国医院诊疗人次变化情况	10
图 9： 2006-2026.1-4 全国医疗卫生机构出院人数变化情况	10
图 10： 2006-2026.1-4 全国医院出院人数变化情况	10
图 11： 2004-2026.1-8 医保基金收入及增速	11
图 12： 2004-2026.1-8 医保基金支出及增速	11
表 1： 2026WCLC 部分国产重点创新药数据整理	4
表 2： 2026ESMO 部分国产重点创新药 LBA 前瞻	5



分析师承诺及简介

本人承诺以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告，本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关。

程培，上海交通大学生物化学与分子生物学硕士，10 年以上医学检验行业+医药行业研究经验，公司研究深入细致，对医药行业政策和市场营销实务非常熟悉。此前作为团队核心成员，获得新财富最佳分析师医药行业 2022 年第 4 名、2021 年第 5 名、2020 年入围，2021 年上海证券报最佳分析师第 2 名，2019 年 Wind“金牌分析师”医药行业第 1 名，2018 年第一财经最佳分析师医药行业第 1 名等荣誉。

闫晓松，复旦大学临床医学学士，悉尼大学金融学硕士，2023 年加入中国银河证券研究院，主要从事创新药研究工作。

免责声明

本报告由中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）向其客户提供。银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。若您并非银河证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险、应首先联系银河证券机构销售部门或客户经理，完成投资者适当性匹配，并充分了解该项服务的性质、特点、使用的注意事项以及若不当使用可能带来的风险或损失。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资咨询建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告而取代自我独立判断。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。银河证券认为本报告资料来源是可靠的，所载内容及观点客观公正，但不担保其准确性或完整性。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断，银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接，银河证券不对其内容负责。链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

银河证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。银河证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河证券。未经银河证券书面授权许可，任何机构或个人不得以任何形式转发、转载、翻版或传播本报告。特提醒客户及公众投资者慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

本报告版权归银河证券所有并保留最终解释权。

评级标准

评级标准	评级	说明
评级标准为报告发布日后的 6 到 12 个月行业指数（或公司股价）相对市场表现，其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准，北交所市场以北证 50 指数为基准，香港市场以恒生指数为基准。	推荐：	相对基准指数涨幅 10% 以上
	中性：	相对基准指数涨幅在 -5%~10% 之间
	回避：	相对基准指数跌幅 5% 以上
	推荐：	相对基准指数涨幅 20% 以上
	谨慎推荐：	相对基准指数涨幅在 5%~20% 之间
	中性：	相对基准指数涨幅在 -5%~5% 之间
	回避：	相对基准指数跌幅 5% 以上

联系

中国银河证券股份有限公司 研究院

机构请致电：

深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 20 层

深广地区：程 曦 0755-83471683 chengxi_yj@chinastock.com.cn

苏一耘 0755-83479312 suyiyun_yj@chinastock.com.cn

上海浦东新区富城路 99 号震旦大厦 31 层

上海地区：林 程 021-60387901 lincheng_yj@chinastock.com.cn

李洋洋 021-20252671 liyangyang_yj@chinastock.com.cn

北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦

北京地区：田 薇 010-80927721 tianwei@chinastock.com.cn

褚 颖 010-80927755 chuying_yj@chinastock.com.cn

公司网址：www.chinastock.com.cn